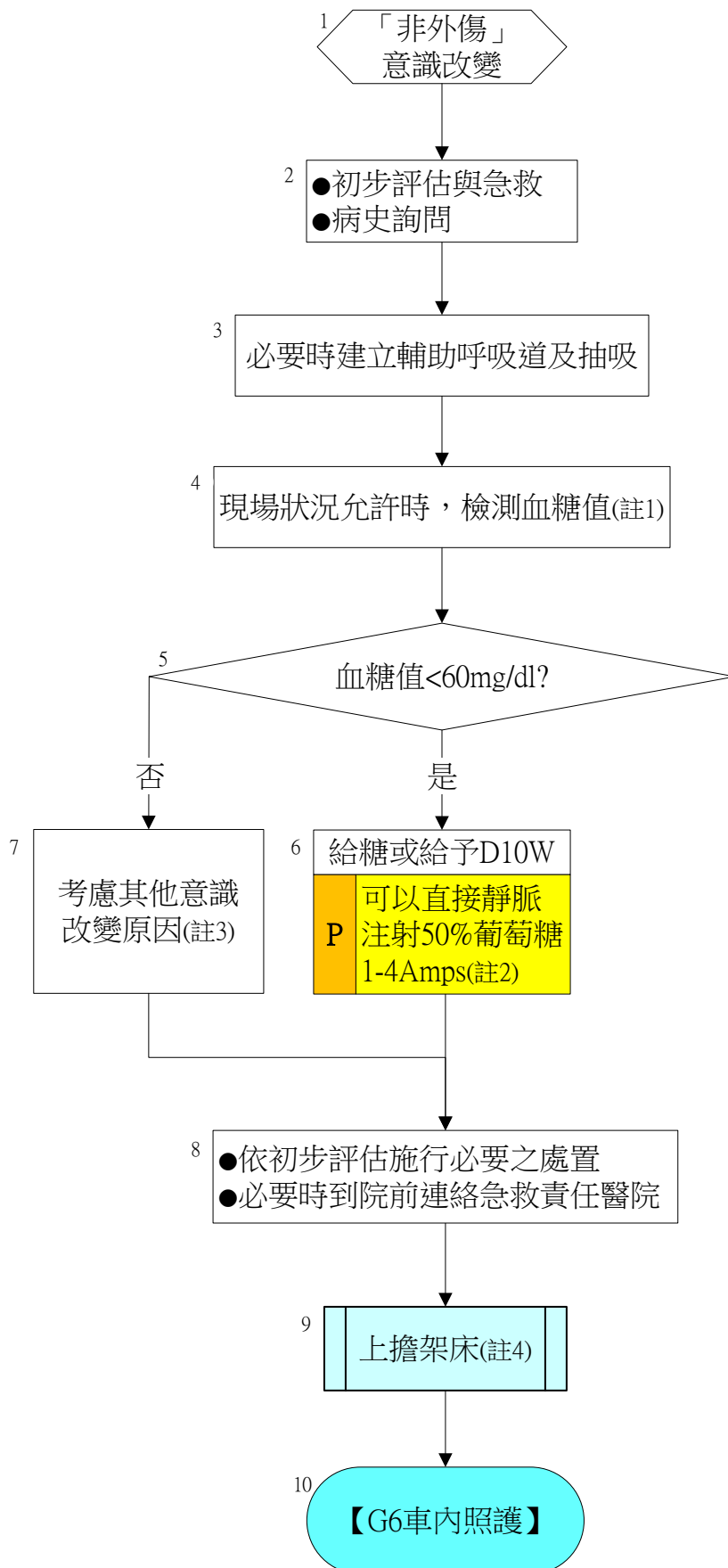




M3 意識改變

程 序



要 旨

- 一、若病人意識不清（GCS<15）或送達醫院前意識變差時即建議使用本程序。
- 二、主要導致意識改變的原因及處置，在到院前常見的有：
 - （一）瀕死徵象或心搏停止-（依【M1 成人無脈搏】處置）
 - （二）無適當呼吸導致體內缺氧或二氧化碳累積-（依【M2 呼吸困難】處置）
 - （三）中風-（依【M6 疑似腦中風】處置）
 - （四）抽搐發作過後之恍神狀態-（依【M4 抽搐】處置）
 - （五）中毒及毒藥物過量-（依【S4 中毒及藥物過量】處置）
 - （六）頭部外傷-（依【T1 頭部外傷】處置）
 - （七）低血容休克-任何組織引起的組織灌流不足，應給予輸液補充、可考慮下肢抬高處置。若為外傷傷者應注意止血、包紮、固定。
 - （八）糖尿病問題-應測量血糖值。

註 解

註1>

- 一、意識不清（GCS<15）之病人務必量測血糖值，除非是長期臥床病人其意識狀態經確認與平常相同者。
- 二、低於60mg/dl或顯示low，應由靜脈給予葡萄糖溶液。若無法建立靜脈路徑，協助病人口服含糖飲料（吞嚥正常）、糖粉或糖膠（吞嚥不正常），儘快送醫，未適當及延遲處理，可能導致病人永久性之腦傷害。
- 三、高於500mg/dl或顯示Hi（High）常合併脫水，考慮注射生理食鹽水並立即送醫。
- 四、外傷傷患評估時應優先考慮頸椎損傷的問題，且應注意止血、包紮、固定。

註2> **P**

若已建立靜脈路徑給予D10W(10%葡萄糖)，可給予D50W(50%葡萄糖)1Amps再觀察；
若未給予D10W，可給予D50W 1-4Amps。

註3>

- 一、應考慮病人意識不清之原因：

A-E-I-O-U-TIPS（酒精Alcohol,腦病變 Encephalopathy,血糖相關

Insulin/Hypoglycemia/DKA/NKHS, 缺氧O2/藥物過量Overdose, 尿毒Uremia,外傷 Trauma,

感染症Infection/腦出血ICH,ICH/腦中風Ischemic stroke,精神病Psychosis,抽搐 Seizure,敗血症Sepsis)

二、到院後治療藥物考慮 BANG (維他命B1,BZD解毒劑Anexate,嗎啡解毒劑 Naloxane,葡萄糖 Glucose)

註4>

一、疑似「腦中風」者，後送姿勢建議為「頭高30度」，並依「M6疑似腦中風」詢問病狀發作時間。

二、若為「口服藥物中毒」且症狀發生在1小時內，後送姿勢建議為「左側躺」。